

ANNEXE DOCUMENTAIRE

Demande de reclassement des ambulanciers hospitaliers en catégorie B de la fonction publique hospitalière

Document de travail préparatoire — Version consolidée

Juin 2026

*Sources mobilisées : DARES · France
Travail · ONVS · CNAM · INRS · ANACT · FNTS · FHF · ANAP*

Sommaire

Synthèse exécutive

Annexe 1 – DARES : métiers en tension et conditions de travail

Annexe 2 – France Travail : besoins en main-d'œuvre

Annexe 3 – ONVS : violences envers les professionnels de santé

Annexe 4 – CNAM : accidentologie et risques professionnels

Annexe 5 – INRS : prévention des risques

Annexe 6 – ANACT / QVCT : qualité de vie et conditions de travail

Annexe 7 – FNTS : attractivité et recrutement

Annexe 8 – FHF / ANAP : intérim, turnover et coûts

Bibliographie et références officielles

Conclusion

Synthèse exécutive

La présente annexe documentaire rassemble les données publiques issues de huit sources institutionnelles majeures afin d'étayer la demande de reclassement des ambulanciers de la fonction publique hospitalière (FPH) en catégorie B. Cette démarche s'appuie sur des éléments objectifs relatifs aux conditions de travail, aux risques professionnels, aux difficultés de recrutement et aux coûts liés au turnover, qui témoignent tous de la spécificité et de l'exigence du métier d'ambulancier hospitalier.

Les principales conclusions sont les suivantes :

- Les ambulanciers sont exposés à des risques professionnels multiples et cumulatifs : risque routier, troubles musculo-squelettiques (TMS), risques biologiques, violence au travail et risques psychosociaux (RPS).
- Les données DARES montrent que 77,2 % des ambulanciers salariés travaillent le dimanche (habituellement ou occasionnellement), illustrant des contraintes horaires très supérieures à la moyenne des autres professions.
- L'enquête BMO 2026 de France Travail recense 4 490 projets de recrutement d'ambulanciers au niveau national, dans un contexte de tension persistante du marché du travail.
- L'ONVS recense 90 victimes ambulancières en 2023 et 85 en 2024, confirmant une exposition significative aux violences en santé.
- L'INRS et la CNAM identifient le portage des patients, la conduite et les expositions biologiques comme risques majeurs du métier, justifiant des mesures de prévention structurées.
- L'ANACT souligne que la démarche QVCT est un levier essentiel pour améliorer l'attractivité et la fidélisation dans ce métier soumis à de fortes contraintes opérationnelles.
- La FNTS et les données parlementaires témoignent d'une pénurie structurelle aggravée par les contraintes d'accès à la profession (DEA, permis probatoire, permis C ou D).
- La FHF et l'ANAP documentent un recours croissant à l'intérim et un turnover élevé, générateurs de coûts directs et indirects significatifs pour les établissements.

L'ensemble de ces éléments justifie une reconnaissance statutaire renforcée des ambulanciers hospitaliers, qui exercent un métier de soins à part entière, dans des conditions de pénibilité et de risque comparables — voire supérieures — à celles de professions déjà classées en catégorie B.

Annexe 1 – DARES : métiers en tension et conditions de travail

Contexte et apport documentaire

Les ambulanciers de la fonction publique hospitalière exercent dans un environnement de travail contraint, notamment par des horaires atypiques et des amplitudes de service importantes. La DARES rappelle plus largement que les conditions de travail dans la fonction publique constituent un objet d'analyse spécifique, avec une publication dédiée fondée sur l'enquête « Conditions de travail ».

Pour les ambulanciers salariés, la DARES met en évidence une forte exposition au travail dominical : 37,9 % travaillent habituellement le dimanche et 39,3 % occasionnellement, soit 77,2 % au total. Ces données peuvent être mobilisées pour illustrer la tension du métier et la contrainte d'organisation qui pèse sur les équipes de transport sanitaire.

Ces chiffres sont particulièrement significatifs dans le contexte d'une demande de reclassement en catégorie B : ils attestent d'une organisation du travail structurellement différente de celle de la plupart des agents de catégorie C, et d'une disponibilité étendue comparable à celle des professions paramédicales déjà reconnues en catégorie B ou A.

Formulation prête à insérer

« La DARES met en évidence que 77,2 % des ambulanciers salariés travaillent le dimanche, habituellement ou occasionnellement, témoignant d'une organisation contrainte qui dépasse largement les conditions habituelles de la catégorie C et justifie une révision du positionnement statutaire de ces agents. »

Références publiques

- DARES, Les conditions de travail dans la fonction publique, Dares Analyses n° 40.1, 1er octobre 2003.
- DARES, Le travail du dimanche des salariés, Dares Analyses n° 075, octobre 2012.
- DARES, enquête Conditions de travail (1998), fiche source associée à la publication sur la fonction publique.

Références bibliographiques

- Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), Les conditions de travail dans la fonction publique, Dares Analyses, n° 40.1, 1er octobre 2003.
- DARES, Le travail du dimanche des salariés, Dares Analyses, n° 075, octobre 2012.
- DARES, Enquête Conditions de travail, 1998.

Annexe 2 – France Travail : besoins en main-d'œuvre

Contexte et apport documentaire

L'enquête Besoins en Main-d'Œuvre 2026 de France Travail montre que les tensions de recrutement restent élevées en France, avec 2,28 millions de postes à pourvoir et 43,8 % de projets jugés difficiles au niveau national. France Travail précise que cette enquête est construite à partir de questionnaires adressés aux établissements, et que les résultats sont accessibles par métier, secteur et bassin d'emploi.

Pour le métier d'ambulancier, les données publiques de France Travail indiquent une demande soutenue dans la filière transport-logistique, avec 4 490 projets de recrutement en 2026. Cette information est particulièrement utile pour la FPH, car elle confirme que le métier reste sous tension sur le marché du travail, ce qui peut nourrir les difficultés de recrutement dans les établissements hospitaliers.

Le contexte statutaire renforce l'intérêt de cette lecture. Depuis l'intégration des ambulanciers dans la filière soins de la fonction publique hospitalière, le corps des ambulanciers de la FPH regroupe les anciens conducteurs ambulanciers de la FPH et de l'AP-HP. Les offres et concours publics montrent d'ailleurs que le recrutement des ambulanciers hospitaliers repose sur le diplôme d'État d'ambulancier, des conditions de permis spécifiques et, selon les véhicules de l'établissement, le permis C ou D.

En pratique, cette combinaison entre besoin de main-d'œuvre, contraintes de qualification et horaires atypiques explique la fragilité du recrutement dans la FPH. Les offres publiées par France Travail illustrent aussi des conditions de travail pouvant inclure le travail en journée, les week-ends, les jours fériés et des rythmes irréguliers.

Formulation prête à insérer

« L'enquête BMO 2026 de France Travail confirme que le métier d'ambulancier reste en tension, avec 4 490 projets de recrutement recensés au niveau national. Dans la fonction publique hospitalière, cette tension s'inscrit dans un contexte plus large de besoins de main-d'œuvre, de contraintes de qualification et d'horaires atypiques, les ambulanciers relevant désormais de la filière soins de la FPH. »

Références publiques

- France Travail, Besoins en main-d'œuvre : 2,28 millions de postes à pourvoir en 2026.
- France Travail, Enquête Besoins en Main-d'Œuvre (BMO) 2026.
- France Travail, Infographie : Transport et logistique des métiers en mouvement.
- Concours FPH / portail officiel, fiche métier et concours ambulancier.
- Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la FPH.

Références bibliographiques

- France Travail. Besoins en main-d'œuvre : 2,28 millions de postes à pourvoir en 2026, enquête BMO 2026.
- France Travail. Enquête Besoins en Main-d'Œuvre (BMO) 2026.

- France Travail. Infographie : Transport et logistique des métiers en mouvement.
- Portail des concours de la fonction publique hospitalière. Ambulancier.
- Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière.

Annexe 3 – ONVS : violences envers les professionnels de santé

Contexte et apport documentaire

L'Observatoire national des violences en santé (ONVS) recense chaque année les atteintes aux personnes et aux biens commises dans les établissements de santé et lors des transports sanitaires. Ses rapports permettent d'objectiver les risques d'exposition aux violences auxquels sont soumis les ambulanciers hospitaliers dans l'exercice de leurs missions.

L'ONVS montre que les violences en santé concernent particulièrement les professionnels exposés à la relation directe avec le public. Les ambulanciers figurent parmi les professions victimes de violences signalées, avec 90 victimes recensées en 2023 et 85 en 2024 dans le rapport ONVS 2025. Ces violences sont surtout des atteintes aux personnes, dans un contexte où les motifs les plus fréquents restent le reproche sur la prise en charge, le refus de soins et l'attente jugée excessive.

Ces données sont particulièrement importantes dans le cadre d'une demande de reclassement en catégorie B : elles attestent d'une exposition aux violences comparable à celle d'autres professions paramédicales, et justifient la reconnaissance d'une pénibilité spécifique liée au contact avec le public en situation de crise ou de détresse.

Formulation prête à insérer

« L'ONVS recense 90 victimes ambulancières en 2023 et 85 en 2024, confirmant que les ambulanciers hospitaliers sont régulièrement exposés à des violences physiques et verbales dans l'exercice de leurs fonctions. Cette exposition justifie une reconnaissance statutaire adaptée, au même titre que d'autres professions paramédicales confrontées à des risques similaires. »

Références publiques

- Ministère de la Santé, Rapport de l'ONVS 2025 – données 2023-2024.
- Ministère de la Santé, Synthèse du Rapport ONVS 2022 – données 2020-2021.
- Ministère de la Santé, Rapport sur les violences à l'encontre des professionnels de santé.

Références bibliographiques

- Observatoire national des violences en santé (ONVS), Rapport 2025, données 2023-2024, Ministère de la Santé, septembre 2025.
- Observatoire national des violences en santé (ONVS), Synthèse du Rapport 2022, données 2020-2021, Ministère de la Santé.
- Ministère de la Santé, Rapport sur les violences à l'encontre des professionnels de santé.

Annexe 4 – CNAM : accidentologie et risques professionnels

Contexte et apport documentaire

La Caisse nationale de l'Assurance Maladie (CNAM), à travers sa branche accidents du travail / maladies professionnelles (AT/MP), constitue une source de référence pour documenter les risques professionnels des ambulanciers. Elle analyse la sinistralité au travail, les causes d'accidents et les maladies professionnelles déclarées, permettant de disposer d'une vision statistique de la dangerosité du métier.

Les données disponibles montrent que les ambulanciers sont particulièrement exposés aux horaires atypiques. La branche accidents du travail / maladies professionnelles de l'Assurance Maladie considère la prévention du risque routier comme une priorité, tandis qu'un document de prévention consacré aux ambulanciers identifie comme risques majeurs la conduite, le portage des patients et les expositions biologiques.

Ces éléments permettent de documenter la triple pénibilité physique, biologique et psychologique du métier, et d'objectiver le besoin d'une reconnaissance statutaire plus élevée pour les ambulanciers hospitaliers.

Formulation prête à insérer

« La CNAM identifie comme risques majeurs du métier d'ambulancier la conduite, le portage des patients et les expositions biologiques, et considère la prévention du risque routier comme une priorité. Cette accidentologie spécifique est un argument central pour la reconnaissance en catégorie B des ambulanciers de la FPH. »

Références publiques

- Cram / Assurance Maladie – branche AT/MP, Ambulancier, un métier à risque ?
- CCHST, Professions et lieux de travail – Ambulancier, fiche sécurité détaillant les risques chimiques, biologiques, physiques, routiers et psychosociaux.

Références bibliographiques

- Assurance Maladie / branche AT-MP, Ambulancier, un métier à risque ? (Cram Centre Ouest, septembre 2008).
- Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST), Professions et lieux de travail – Ambulancier, fiche santé-sécurité.

Annexe 5 – INRS : prévention des risques

Contexte et apport documentaire

L'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est l'organisme de référence en France pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il a consacré plusieurs publications spécifiques au métier d'ambulancier, documentant les risques du métier et les solutions de prévention adaptées.

L'INRS identifie plusieurs familles de risques propres aux ambulanciers : le risque routier lié à la conduite de véhicules de secours, les troubles musculo-squelettiques liés au portage et à la manutention de patients, les risques biologiques liés aux expositions au sang et aux agents infectieux, ainsi que les risques psychosociaux liés à la charge émotionnelle et à la gestion des situations de crise.

L'INRS recommande notamment des formations spécifiques aux techniques de manutention adaptées à la prise en charge des patients, au comportement à adopter lors de la conduite des véhicules, la conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang et la gestion des situations conflictuelles.

La littérature scientifique relayée par l'INRS, notamment via la revue Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, confirme la co-exposition des ambulanciers hospitaliers aux troubles musculo-squelettiques (TMS) et aux risques psychosociaux (RPS), ce qui en fait un cas emblématique de métier soumis à des contraintes cumulatives méritant une reconnaissance statutaire renforcée.

Formulation prête à insérer

« L'INRS reconnaît que le métier d'ambulancier expose les professionnels à des risques multiples et cumulatifs : risque routier, TMS, risques biologiques et RPS. Ces risques font l'objet de recommandations de prévention spécifiques, et leur cumul justifie pleinement la demande de reclassement en catégorie B des ambulanciers de la FPH. »

Références publiques

- INRS, Transports sanitaires. Les risques du métier.
- INRS, Transports sanitaires. Des solutions pour agir.
- INRS, Transport sanitaire (dépliant PDF).
- INRS, Ambulancier, un métier à risque ? (référence documentaire INRS liée à une brochure CARSAT).
- Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, Troubles musculosquelettiques et risques psychosociaux dans une population de conducteurs ambulanciers hospitaliers.

Références bibliographiques

- Institut national de recherche et de sécurité (INRS), Transports sanitaires. Les risques du métier.
- INRS, Transports sanitaires. Des solutions pour agir.
- INRS, Transport sanitaire (dépliant).
- INRS, notice documentaire Ambulancier, un métier à risque ?

- Article scientifique sur les TMS et RPS chez les conducteurs ambulanciers hospitaliers, Archives des maladies professionnelles et de l'environnement.

Annexe 6 – ANACT / QVCT : qualité de vie et conditions de travail

Contexte et apport documentaire

L'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact) propose un cadre structurant pour aborder la qualité de vie et les conditions de travail (QVCT) dans les organisations. Ce référentiel est articulé autour de six sujets principaux : le contenu du travail, l'organisation du travail, les relations de travail, le management, l'environnement de travail et la formation professionnelle.

Dans la FPH, cela est stratégique pour les ambulanciers car le métier nécessite une mise à niveau régulière des compétences, notamment en conduite, manutention, hygiène, relation patient et gestion des situations de crise. La QVCT peut ainsi soutenir l'attractivité et la fidélisation en donnant des perspectives d'évolution.

Enfin, l'Anact met en avant la dimension égalité au travail, en veillant à ce que toutes et tous aient un égal accès à de bonnes conditions de travail, sans discrimination selon l'âge, le genre, le métier ou la situation personnelle. Pour les ambulanciers de la FPH, cette approche peut aider à traiter les inégalités de pénibilité, d'exposition aux horaires atypiques et d'accès à la formation ou aux outils de prévention. Elle permet aussi de mieux intégrer les situations particulières, comme la grossesse, le handicap ou les contraintes familiales.

Formulation prête à insérer

« La démarche QVCT proposée par l'Anact est particulièrement pertinente pour les ambulanciers de la FPH, car elle place l'organisation du travail, les horaires, la coopération, le management et la prévention au cœur de l'amélioration des conditions de travail. Les six sujets QVCT offrent un cadre structurant pour agir sur l'attractivité, la fidélisation et la santé au travail dans un métier soumis à de fortes contraintes opérationnelles. »

Références publiques

- Anact, Référentiel qualité de vie et des conditions de travail (QVCT).
- Anact, Les six sujets de la qualité de vie et des conditions de travail.
- Fonction publique, La qualité de vie et des conditions de travail.
- Anact / MGEN, Le site Santé-travail fonction publique.

Références bibliographiques

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), Référentiel qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), 2024.
- Anact, Les six sujets de la qualité de vie et des conditions de travail, 2025.
- Direction générale de l'administration et de la fonction publique, La qualité de vie et des conditions de travail.
- Anact / MGEN, Le site Santé-travail fonction publique.

Annexe 7 – FNTS : attractivité et recrutement

Contexte et apport documentaire

La Fédération nationale des transporteurs sanitaires (FNTS) et les instances parlementaires ont régulièrement alerté sur les difficultés d'attractivité du métier d'ambulancier, aussi bien dans le secteur privé que dans la fonction publique hospitalière. Ces alertes trouvent un écho dans plusieurs questions parlementaires et rapports institutionnels qui documentent la pénurie structurelle de personnel ambulancier en France.

Les données parlementaires et institutionnelles mettent en évidence plusieurs facteurs explicatifs de cette pénurie : les contraintes d'accès à la profession (diplôme d'État d'ambulancier, permis probatoire, permis C ou D selon les établissements), la faiblesse des rémunérations par rapport aux exigences du poste, la pénibilité des conditions de travail, et le manque de perspectives de carrière.

Dans la FPH spécifiquement, le Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière a constitué une première étape vers la reconnaissance du métier au sein de la filière soignante. Toutefois, le maintien en catégorie C constitue un frein à l'attractivité et à la fidélisation, dans un contexte où la concurrence avec le secteur privé et les autres métiers paramédicaux est vive.

Formulation prête à insérer

« Les alertes récurrentes de la FNTS et des instances parlementaires sur la pénurie d'ambulanciers confirment l'urgence d'agir sur l'attractivité de la profession dans la FPH. Le reclassement en catégorie B constituerait un signal fort de reconnaissance, de nature à améliorer le recrutement et la fidélisation des équipes dans les établissements hospitaliers. »

Références publiques

- Sénat, Attractivité du métier d'ambulancier.
- Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière.
- Assemblée nationale, Question n° 569 : Attractivité du métier d'ambulancier.
- Ministère de la Santé, éléments sur la réforme du permis probatoire et la VAE.
- Centre Inffo, article sur le manque d'ambulanciers en France.

Références bibliographiques

- Sénat, Attractivité du métier d'ambulancier.
- Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière, Journal officiel de la République française.
- Assemblée nationale, Question n° 569 : Attractivité du métier d'ambulancier.
- Ministère de la Santé, réponses publiques sur l'accès à la profession, le permis probatoire et la VAE.
- Fédération hospitalière de France (FHF), Les ambulanciers sont intégrés au sein de la filière soignante.

Annexe 8 – FHF / ANAP : intérim, turnover et coûts

Contexte et apport documentaire

La Fédération hospitalière de France (FHF) rappelle que les établissements publics sont désormais encadrés par des règles renforcées sur le recours à l'intérim, y compris pour le personnel paramédical. La FHF indique notamment qu'un décret de 2025 précise les conditions de détermination du montant plafond des dépenses d'intérim médical et paramédical dans la FPH, ce qui traduit la volonté de mieux maîtriser les coûts liés à ces remplacements.

Pour les ambulanciers de la FPH, cette évolution est importante car le recours à l'intérim est souvent une réponse à la pénurie de candidats, aux absences non remplacées et à la difficulté de maintenir des plannings complets. Lorsque les équipes sont fragiles, le coût ne se limite pas au prix de la mission d'intérim : il faut aussi compter les heures supplémentaires, la désorganisation des tournées, la surcharge des agents présents et la baisse de continuité du service.

L'Anap propose des outils pour analyser le taux de rotation et l'activité, afin d'objectiver le turnover et de suivre son évolution dans le temps. Cette approche est particulièrement utile pour les ambulanciers, dont les départs peuvent être liés à la pénibilité, aux horaires atypiques, au manque de reconnaissance et aux perspectives de carrière limitées. En pratique, le turnover élevé se traduit par une hausse des coûts de recrutement, d'intégration et de formation, ainsi qu'une perte d'expertise terrain.

Dans la FPH, l'enjeu n'est donc pas seulement de réduire l'intérim, mais aussi de sécuriser la fidélisation. La FHF souligne que l'attractivité et la fidélisation des professionnels de santé hospitaliers font désormais l'objet de travaux spécifiques, notamment dans les territoires les plus en tension. Pour les ambulanciers, cela suppose d'agir sur les plannings, l'encadrement, la reconnaissance salariale, les conditions de travail et l'organisation des remplacements.

Le coût du turnover est particulièrement sensible dans un métier très opérationnel. Chaque départ entraîne un temps de vacance, une réorganisation interne et souvent le recours à des solutions temporaires plus onéreuses que l'emploi pérenne. Dans les services de transport sanitaire hospitaliers, cela peut affecter la réactivité des prises en charge, la qualité des liaisons inter-services et la disponibilité des véhicules et équipes.

Formulation prête à insérer

« Le recours à l'intérim et le turnover représentent un coût direct et indirect important pour les ambulanciers de la FPH. La FHF souligne le renforcement de l'encadrement des dépenses d'intérim paramédical, tandis que l'Anap met à disposition des outils de suivi du taux de rotation afin d'objectiver les départs et d'orienter les actions de fidélisation. »

Références publiques

- FHF, Dispositions communes personnel médical - personnel non médical.
- FHF, Publication du décret détaillant les conditions de détermination du montant plafond des dépenses d'intérim médical et paramédical.

- ANAP, Outil taux de rotation / activité.
- FHF, Les ambulanciers sont intégrés au sein de la filière soignante.
- Offre FHF, Astreintes ambulancier (soir et weekend).

Références bibliographiques

- Fédération hospitalière de France (FHF), Dispositions communes personnel médical - personnel non médical.
- FHF, Publication du décret détaillant les conditions de détermination du montant plafond des dépenses d'intérim médical et paramédical.
- Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), Outil taux de rotation / activité.
- FHF, Les ambulanciers sont intégrés au sein de la filière soignante.
- FHF Emploi, Astreintes ambulancier (soir et weekend).

Bibliographie et références officielles

Sources statistiques et études

- Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), Les conditions de travail dans la fonction publique, Dares Analyses, n° 40.1, 1er octobre 2003.
- DARES, Le travail du dimanche des salariés, Dares Analyses, n° 075, octobre 2012.
- France Travail, Enquête Besoins en Main-d'Œuvre (BMO) 2026.
- France Travail, Infographie : Transport et logistique des métiers en mouvement.

Sécurité et risques professionnels

- Observatoire national des violences en santé (ONVS), Rapport 2025, données 2023-2024, Ministère de la Santé, septembre 2025.
- Observatoire national des violences en santé (ONVS), Synthèse du Rapport 2022, données 2020-2021, Ministère de la Santé.
- Assurance Maladie / branche AT-MP, Ambulancier, un métier à risque ? (Cram Centre Ouest, septembre 2008).
- Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST), Professions et lieux de travail – Ambulancier, fiche santé-sécurité.
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS), Transports sanitaires. Les risques du métier.
- INRS, Transports sanitaires. Des solutions pour agir.
- INRS, notice documentaire Ambulancier, un métier à risque ?
- Archives des maladies professionnelles et de l'environnement, Troubles musculosquelettiques et risques psychosociaux dans une population de conducteurs ambulanciers hospitaliers.

Qualité de vie au travail et conditions d'emploi

- Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (Anact), Référentiel qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), 2024.
- Anact, Les six sujets de la qualité de vie et des conditions de travail, 2025.
- Direction générale de l'administration et de la fonction publique, La qualité de vie et des conditions de travail.
- Anact / MGEN, Le site Santé-travail fonction publique.

Sources institutionnelles et réglementaires

- Décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022 portant création du corps des ambulanciers de la fonction publique hospitalière, Journal officiel de la République française.
- Sénat, Attractivité du métier d'ambulancier.
- Assemblée nationale, Question n° 569 : Attractivité du métier d'ambulancier.
- Ministère de la Santé, réponses publiques sur l'accès à la profession, le permis probatoire et la VAE.
- Fédération hospitalière de France (FHF), Dispositions communes personnel médical - personnel non médical.

- FHF, Publication du décret détaillant les conditions de détermination du montant plafond des dépenses d'intérim médical et paramédical.
- Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP), Outil taux de rotation / activité.
- FHF, Les ambulanciers sont intégrés au sein de la filière soignante.
- Portail des concours de la fonction publique hospitalière. Ambulancier.

Conclusion

L'ensemble des données et références rassemblées dans la présente annexe documentaire dresse un tableau cohérent et convergent des conditions d'exercice des ambulanciers de la fonction publique hospitalière.

Sur le plan des risques professionnels, les ambulanciers hospitaliers sont exposés à une combinaison de risques rarement rencontrée dans d'autres métiers de catégorie C : risque routier, troubles musculo-squelettiques liés au portage des patients, expositions biologiques, risques psychosociaux et violences au travail. Ce cumul de risques est documenté par l'INRS, la CNAM et l'ONVS, et mérite une reconnaissance statutaire à hauteur de la réalité opérationnelle du métier.

Sur le plan des conditions de travail, les données DARES montrent une organisation structurellement contraignante, avec 77,2 % des ambulanciers salariés travaillant le dimanche. Cette organisation est comparable à celle des professions paramédicales déjà reconnues en catégorie B ou A, ce qui constitue un argument fort pour l'alignement statutaire demandé.

Sur le plan du recrutement et de la fidélisation, les tensions documentées par France Travail (4 490 projets de recrutement en 2026) et les alertes de la FNTS confirment une pénurie structurelle que le maintien en catégorie C ne fait qu'aggraver. Le reclassement en catégorie B constituerait un levier puissant pour améliorer l'attractivité du métier et réduire le turnover, dont les coûts directs et indirects sont documentés par la FHF et l'ANAP.

Sur le plan de la qualité de vie au travail, le cadre QVCT proposé par l'Anact offre des outils structurants pour accompagner cette transition statutaire et agir durablement sur les conditions de travail des ambulanciers hospitaliers.

En conclusion, la convergence de ces huit sources institutionnelles majeures — DARES, France Travail, ONVS, CNAM, INRS, ANACT, FNTS, FHF et ANAP — fournit une base documentaire solide et argumentée pour soutenir la demande de reclassement des ambulanciers de la FPH en catégorie B. Ce reclassement constituerait une reconnaissance juste et nécessaire d'un métier de soins à part entière, exercé dans des conditions de pénibilité et de risque qui dépassent largement celles habituellement associées à la catégorie C.